PROFESIONAL

EJE 1 · TRANSFORMACIONES DEL CUIDADO Y HUMANIZACIÓN

EL CUIDADO HUMANIZADO TAMBIÉN SE DEMUESTRA

Beneficios para quien cuida, quien es cuidado y la institución

Prof. Lic. Domecq, Celeste[1] · Prof. Lic. Curletti, Sabrina Soledad[2]

[1] FMED (Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires) · [2] Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS ALFREDO LANARI
Universidad de Buenos Aires

1 INTRODUCCIÓN

El cuidado humanizado, poner a la persona en el centro, es la esencia de la enfermería y se apoya en la teoría del cuidado humano de Watson (2012). Con frecuencia se lo trata como un valor ético o un eslogan. La Joint Commission (2010) propuso una hoja de ruta para hospitales centrada en la comunicación efectiva y en la atención centrada en el paciente y la familia. Este trabajo muestra que cuidar con calidez y buena comunicación también beneficia a quien cuida, a quien es cuidado y a su familia, y a la institución.

2 OBJETIVOS

General: reunir evidencia sobre los beneficios de componentes del cuidado humanizado (comunicación, continuidad, participación de la familia y autocuidado) y complementarla con la experiencia profesional.

- Identificar beneficios para el profesional.
- Describir beneficios para el paciente y su familia, incluida la terapia intensiva.
- Reconocer el impacto para la institución.

3 METODOLOGÍA

Diseño: revisión bibliográfica narrativa, complementada con reflexión desde la experiencia profesional.

Fuentes: metaanálisis, estudios multicéntricos, informes de gestión hospitalaria y documentos de calidad (2010-2026), localizados en búsquedas en línea en octubre de 2026.

Marco teórico: teoría del cuidado humano de Jean Watson.

Experiencia: 20 años trabajando desde el cuidado humanizado (proyecto Mimos al Alma). Es una observación reflexiva, no medida sistemáticamente.

Aspectos éticos: fuentes publicadas, sin datos de pacientes.

4 RESULTADOS

Los componentes del cuidado humanizado se asocian con beneficios en tres niveles.

PARA EL PROFESIONAL

Más satisfacción, menos desgaste. En un metaanálisis de enfermería (11 estudios, 4.054 profesionales), la satisfacción por compasión se asoció de forma inversa con el burnout (r = −0,446; Zhang et al., 2018). Para Watson (2012), el cuidado de uno mismo es parte de cuidar.

En Argentina, más del 80 % de las enfermeras de terapia intensiva presenta burnout moderado o alto (Torre et al., 2019).

PARA EL PACIENTE Y SU FAMILIA

Comunicación al alta. Con comunicación estructurada (19 ensayos, 3.953 pacientes) hubo menos reingresos, más adherencia al tratamiento y más satisfacción (Becker et al., 2021).

Transición del hospital a casa. El seguimiento y el apoyo redujeron 22 % las probabilidades de reingreso a 30 días con intervenciones de baja complejidad (126 estudios; Tyler et al., 2023).

Terapia intensiva. El paquete ABCDEF (prevenir el delirio, movilizar y hacer participar a la familia) se asoció con menos reingresos a UCI y mejor supervivencia (15.226 pacientes; Pun et al., 2019). Apunta a prevenir el síndrome post-UCI: secuelas físicas, cognitivas y psicológicas en el paciente y su familia (De la Torre Ramos et al., 2025). El Proyecto HU-CI propone buenas prácticas de humanización en UCI (2019).

9,1 % vs. 13,5 %
reingresos a 30 días con comunicación estructurada vs. atención habitual

OR 0,54
de reingreso a UCI con el paquete ABCDEF completo

PARA LA INSTITUCIÓN

Retener y no reingresar también es ahorro. En hospitales de EE. UU., reemplazar a un enfermero cuesta en promedio USD 60.090, y cada punto de rotación equivale a unos USD 295.000 por año (NSI, 2026). Menos reingresos y un equipo que permanece reducen ese gasto.

En Argentina, una dotación de una enfermera cada tres pacientes se relacionó con burnout en terapia intensiva (Torre et al., 2019).

Los costos económicos son de EE. UU.; faltan datos locales.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

Cuidar con humanidad no es solo un valor: se asocia con mejores resultados para quien cuida, para quien es cuidado y para la institución.

La mayoría de los estudios son asociaciones y miden componentes del cuidado humanizado, no el concepto completo. La experiencia de 20 años aporta una mirada práctica, pero no fue medida: el próximo paso es medirla.

6 APORTE A ENFERMERÍA

Recordar que el cuidado humanizado es nuestra esencia, también en entornos muy técnicos y de alta especialidad. Incorporar indicadores simples (satisfacción, reingresos, bienestar del equipo) para demostrar su valor en cada servicio.

7 DESDE LA EXPERIENCIA

MI EXPERIENCIA (20 AÑOS · MIMOS AL ALMA)

Trabajar desde el cuidado humanizado me permitió trabajar mejor y sentirme mejor, y percibir una mejor atención para los pacientes, las familias y la institución. Es una observación reflexiva, no una medición.

LO QUE SIGUE: MEDIR

Registrar indicadores simples, como satisfacción de pacientes y familias, reingresos, ausentismo y bienestar del equipo, para pasar de la percepción a los datos.

8 REFERENCIAS

Zhang, Y. Y., Zhang, C., Han, X. R., Li, W., & Wang, Y. L. (2018). Determinants of compassion satisfaction, compassion fatigue and burnout in nursing: A correlative meta-analysis. *Medicine, 97*(26), e11086.

Becker, C., Zumbrunn, S., Beck, K., et al. (2021). Interventions to improve communication at hospital discharge and rates of readmission: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Network Open, 4*(8), e2119346.

Tyler, N., Hodkinson, A., Planner, C., et al. (2023). Transitional care interventions from hospital to community to reduce health care use and improve patient outcomes: A systematic review and network meta-analysis. *JAMA Network Open, 6*(11), e2344825.

Pun, B. T., Balas, M. C., Barnes-Daly, M. A., et al. (2019). Caring for critically ill patients with the ABCDEF bundle: Results of the ICU Liberation Collaborative in over 15,000 adults. *Critical Care Medicine, 47*(1), 3-14.

NSI Nursing Solutions, Inc. (2026). *2026 NSI National Health Care Retention & RN Staffing Report.*

Torre, M., Santos Popper, M. C., & Bergesio, A. (2019). Prevalencia de burnout entre las enfermeras de cuidados intensivos en Argentina. *Enfermería Intensiva, 30*(3), 108-115.

De la Torre Ramos, M. Á., Alonso Ovies, Á., & Velayos Amo, C. (Eds.). (2025). *Abordaje del síndrome postcuidados intensivos.* Elsevier.

Watson, J. (2012). *Human caring science: A theory of nursing* (2.ª ed.). Jones & Bartlett Learning.

The Joint Commission. (2010). *Advancing effective communication, cultural competence, and patient- and family-centered care: A roadmap for hospitals.*

Proyecto HU-CI. (2019). *Manual de buenas prácticas de humanización en Unidades de Cuidados Intensivos* (rev. 2019). https://proyectohuci.com

APUBA

.UBA CIENCIAS MÉDICAS